

Compléments fascicule 12

CFAO · DMSM / traçabilité · Chir épulis-grenouillettes-kystes · Hygiène prothèse · Rôle AD

1 · CFAO (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur)

Principe : empreinte **optique** en bouche (caméra intra-buccale) → transmise au laboratoire via internet → conception virtuelle de la prothèse → usinage dans un bloc de céramique ou composite (par addition ou soustraction).

Les 3 méthodes

Selon qui conçoit et usine la prothèse

Item	Détail
Méthode indirecte	Empreinte optique en bouche → labo conçoit virtuellement → usine dans son bloc
Méthode directe	Empreinte optique + conception + usinage au cabinet par le praticien
Autre	Empreinte classique (PE + matériau) → modèle scanné → transmis au labo

Avantages / Inconvénients de l'empreinte optique

À connaître pour le concours

Item	Détail
Avantages	Gain de temps (~2 min) · précision (erreurs visibles direct) · stabilité (pas de déformation) · pas d'étapes chronophages (transport, coulée, cire) · confort patient (pas de réflexes nauséeux)
Inconvénients	Pas assez précis pour les bridges complets · ouverture buccale suffisante nécessaire · postérieurs difficiles · coût élevé
Apports cliniques	Orientation du modèle · ligne de finition très précise · zoom · double empreinte possible (sang dans le sulcus) · 3D · occlusion dynamique · empreinte couleur (intérêt en implanto)

Prise d'empreinte optique — protocole

4 étapes

Item	Détail
1/ Préparation	Isolation du site de la salive · séchage important
2/ Coating	Poudrage qui crée une microtexture pour éviter le rayonnement (pas nécessaire avec toutes les caméras)
3/ Empreinte	Caméra manipulée comme un stylo ou à pleine main · vue par vue ou linéaire · enregistre préparation + antagoniste + occlusion (4-10 min)
4/ Transfert au labo	Via internet

Usinage de la prothèse

2 modes possibles

Item	Détail
Par addition	Méthode de superposition · polymérisation des résines · fusion au laser
Par soustraction	Par fraisage (le plus courant — bloc céramique/composite)

2 · Traçabilité des DMSM (Dispositifs Médicaux Sur Mesure)

Définition : tout DMSM (couronne, bridge, prothèse amovible, gouttière...) doit être **tracé**. Le praticien établit une **fiche navette** qui suit le travail entre le cabinet et le laboratoire.

Fiche navette (à remplir par le praticien)

À connaître par cœur — souvent au concours

Item	Détail
Identification praticien	Cachet et signature du praticien · n° du praticien
Identification patient	Identification CODÉE du patient (anonymat — sexe, âge, visage)
Identification laboratoire	Cachet et signature du laboratoire · n° du labo
Date de prescription	Date d'émission de la fiche
Nature et description du DMSM	Type : fixe · amovible · provisoire · orthodontique · implanto-portée · autre · schéma dentaire
Dates intermédiaires	Dates des étapes intermédiaires de réalisation
Date de finition et livraison	Date de fin de réhabilitation
Date de pose du DMSM	Pose en bouche par le praticien

Fiche de traçabilité (établie par le prothésiste — accompagne le retour)

À garder 5 ans dans le dossier du patient + un exemplaire au patient

Item	Détail
N° de lot	Du matériau utilisé
Origine	Du produit
Descriptif	Du matériau (céramique, métal, résine...)
Normes ISO	Du produit
N° CE	Marquage CE

Déclaration de conformité (établie aussi par le prothésiste) doit comprendre : nom et adresse du fabricant · données identifiant le dispositif · usage exclusif d'un patient déterminé · nom du professionnel de santé prescripteur · caractéristiques spécifiques · déclaration de conformité aux articles R5211-621 à R5211-23 du Code de la Santé Publique.

3 · Chirurgie des épulis, grenouillettes et kystes

3 lésions à connaître

Lésions bénignes des tissus mous

Item	Détail
Épulis	Tumeur bénigne de la gencive (hyperplasique, granulomateuse ou fibreuse). Souvent post-irritation locale (tartre, prothèse mal adaptée, hormones grossesse)
Grenouillette	Kyste du plancher buccal (canal de Wharton de la glande sub-mandibulaire) — aspect bleuté translucide
Kyste	Cavité pathologique remplie de liquide ou de matière semi-solide (kyste apical, kyste folliculaire, kyste résiduel...)

Plateau chir épulis / grenouillette / kyste

Protocole proche d'une chirurgie d'avulsion avec lambeau

Item	Détail
Anesthésie	Plateau anesthésie locale
Incision	Bistouri + lame
Décollement	Décolleurs · précelles à lambeau
Énucléation	Curette de Lucas · pince Allis (préhension de la lésion) · ciseaux
Si kyste osseux	Fraise Zekrya + CA bague rouge (ostéotomie d'accès)
Examen anatomopathologique	Pot avec formol — la pièce est envoyée pour examen histologique systématiquement
Hémostase	Compresse · éponge hémostatique · sutures
Sutures	Porte-aiguille · fil + aiguille · ciseaux

4 · Hygiène prothétique — conseils au patient

Prothèse FIXE (couronnes, bridges, inlay-onlay)

Hygiène quotidienne adaptée

Item	Détail
Brossage	2-3 fois par jour avec brosse souple
Inter-dentaire	Fil dentaire ou brossettes inter-dentaires (taille adaptée)
Bridges et inters	Indispensable : passe-fil pour glisser sous les inters · brossettes pour piliers
Hydropulseur	Recommandé en complément (sous les inters, autour des piliers)
Visites	Contrôle 1-2x par an

Prothèse AMOVIBLE (PPA, PAC/PAT)

Hygiène spécifique : prothèse + bouche

Item	Détail
Après chaque repas	Retirer la prothèse · brosser avec brosse à prothèse + savon doux (PAS de dentifrice abrasif) · rincer
Quotidiennement	Trempage dans solution antiseptique nettoyante (1x/jour)
Nuit	Retirer la prothèse la nuit — repos des muqueuses · conservation dans un récipient avec eau
Bouche	Brosser la langue et les gencives · masser les zones d'appui · si dents restantes : brossage classique
Alimentation	Commencer mou, progresser · couper en petits morceaux
Contrôles	Tous les 6-12 mois (réajustement, rebasage, vérification occlusion)

5 · Rôle de l'AD en prothèse — synthèse

Rôle général (cf. début du fascicule)

À toutes les étapes

Item	Détail
Installation	Installer le patient (position adaptée à l'acte)
Présentation matériel	Présenter au praticien matériel et matériaux selon la séquence opératoire
Isolation salivaire	Assurer l'isolation (dépend du type de prothèse et de l'étape)
Aide opératoire	Écarter lèvres, langue, joues
Fin de séance	Débarrasser le fauteuil (patient propre, sans pâte à empreinte sur le visage !)
Sortie	Raccompagner le patient

Étapes SPÉCIFIQUES à la prothèse

À retenir pour le concours

Item	Détail
Empreintes	Rinçage, désinfection et conditionnement des empreintes avant envoi au labo
Fiche navette	Élaboration de la fiche navette du laboratoire (cf. partie DMSM)
Liaison labo	Liaison avec le laboratoire (transmission, suivi, questions techniques)
Livraison DMSM	S'assurer de la livraison des DMSM avant la séance de pose
Planification	Planification des RDV (séances multiples souvent : empreintes, essayages, pose, équilibration)

À retenir absolument : fiche navette = identification praticien + patient codé + labo + dates · fiche traçabilité = n° lot, origine, descriptif, normes ISO, n° CE · **conservation 5 ans** + 1 exemplaire au patient · pièce chir = formol + envoi anapath.